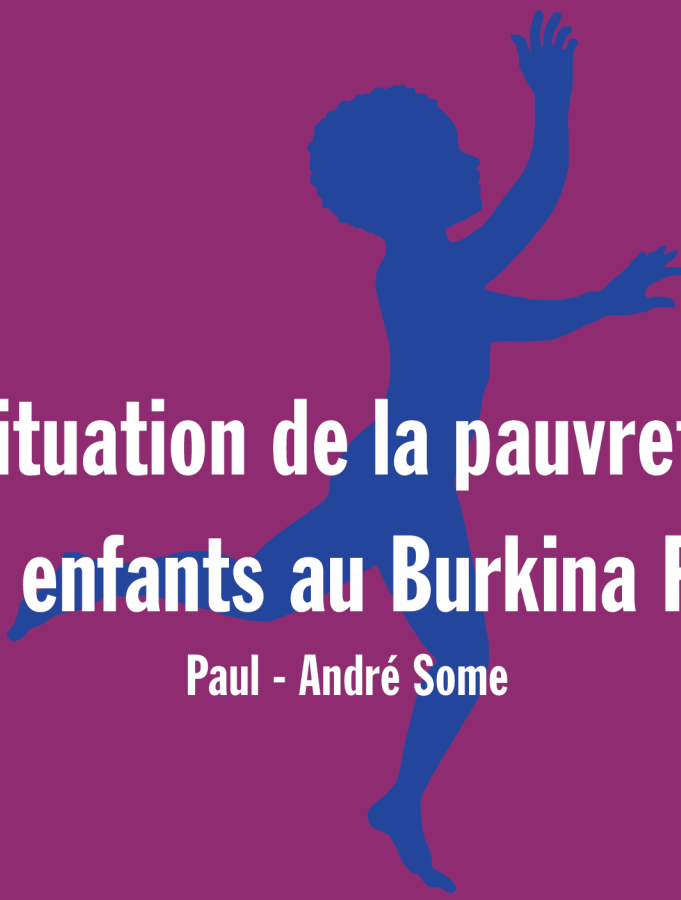




Situation de la pauvreté des enfants au Burkina Faso

Paul - André Some



The African Child
Policy Forum



Table des matières

Préface	1
Liste des sigles et abréviations	3
Introduction	5
Brève présentation du pays	5
Introduction à la question de la pauvreté des enfants	6
L'état de pauvreté des enfants au Burkina Faso: Résumé Factuel	8
I. Déterminants de la pauvreté des enfants	10
1.1. Conséquence de la pauvreté des enfants et ses manifestations	11
1.2. La déscolarisation-non scolarisation et le travail des enfants	11
1.3. Les enfants dans/de la rue	13
1.4. L'état sanitaire et nutritionnel des enfants	14
II. Réponses développées au niveau national	16
2.1. Actions du gouvernement	16
2.2. Actions des institutions et ONGs	18
III. Recommandations	20
Conclusion	21
Références bibliographiques	22



Préface

Les enfants représentent un pourcentage important à l'échelle internationale des individus vivant avec un très faible revenu et touchés par une pauvreté extrême. Au moins 600 millions d'enfants dans le monde ont moins de 18 ans et survivent avec moins de un dollar par jour; 40 pourcents de ces enfants vivent dans des pays en développement. Chaque seconde, un enfant vivant dans un pays en développement se trouve privé des chances minimums de survie.

Grandir en étant pauvre signifie être désavantagé depuis la naissance; cela signifie des vies plus courtes; cela implique des coûts économiques et sociaux énormes pour les sociétés; et cela gâche un précieux potentiel humain. Tout cela s'ajoute à la responsabilité morale énorme de s'attaquer à la question de la pauvreté de l'enfant. Dans le même temps, les changements économiques et sociaux défient les sociétés africaines d'améliorer les conditions de vie de tous les enfants, tout en s'assurant que l'inégalité ne prive les enfants pauvres des opportunités que la vie offre.

En dépit de l'incidence grandissante de la pauvreté infantile sur le continent, la plupart des données disponibles sont anecdotiques, dépassées et souvent d'une qualité discutable. La ou les rapports sont utilisés, cela implique souvent que les données qui y figurent proviennent du milieu familial et que sont finalement mises en lumière, dans ces rapports, les différences qui existent au regard notamment des milieux familiaux. La pauvreté infantile est négligée lorsque sont entreprises des recherches sérieuses, dans la mesure où les enfants n'ont généralement pas la possibilité de s'exprimer. Il y a là une présomption infondée selon laquelle les enfants réagissent de la même manière que les adultes aux interventions visant le développement, ou que les politiques formulées par les adultes iront forcément dans le même sens que l'intérêt supérieur de l'enfant.

Les données et l'information influencent la politique. Aussi, une information de très bonne qualité est indispensable au développement de politiques, dans la mesure où il est important de pouvoir avoir accès à des données pertinentes pour obtenir des interventions réussies. Des meilleurs données statistiques et davantage d'analyse effective constituent le premier pas pour influencer la politique et un changement positif sur ce plan. La conduite d'études pour construire une base de connaissance sur la question et diffuser les résultats aussi largement que

possible est fondamentale dans le domaine du plaidoyer politique. African Child Policy Forum a par conséquent initié des études sur la pauvreté infantile et les expériences de politique dans des pays africains sélectionnés. Les résultats des études visaient à informer la Troisième Conférence de Politique sur l'Enfant Africain, organisée sous le thème de la pauvreté infantile et tenue les 12 et 13 mai 2008 au Centre de Conférences des Nations Unies à Addis Abeba. Cette publication fait partie de ces études dont nous avons passé commande, et nous sommes heureux de la rendre disponible auprès d'un large public.

Assefa Bequele (Dr)
Directeur Executif
African Child Policy Forum (ACPF)

Liste des sigles et abréviations

AEC	Aide à l'Enfance Canada
APRODEB	Action pour la Promotion des Droits de l'Enfant au Burkina Faso
CEBNF	Centres d'Éducation de Base Non Formelle
CEDEF	Convention sur l'Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l'égard des Femmes
COBUFADE	Coalition au Burkina Faso sur les Droits de l'enfant
CSLP	Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
GTZ	Gesellschaft Fuer Technische Zusammenarbeit (Coopération Allemande)
INSD	Institut National de la Statistique et de la Démographie
LUTRENA	Lutte contre le Trafic des Enfants
MASSN	Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PTF	Partenaires Techniques et Financiers
SMIG	Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance



Introduction

Brève présentation du pays

Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé situé en Afrique de l'Ouest. Il couvre une superficie de 274,200 km et est limité par six pays : le Mali, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Niger. Il constitue un



important carrefour routier entre tous ces pays. La population totale estimée à partir du recensement de 2005 est de 13,902,972 habitants. Il s'agit d'une population à composante essentiellement jeune, plus de la moitié de la population (55%) ayant moins de 15 ans. Le Burkina Faso figure parmi les pays les moins avancés avec un Indice de Développement Humain Durable estimé à 0,348 en 1998 (Rapport sur le Développement Humain Durable 2000). Près de 45% de la population burkinabé vit en dessous de seuil absolu national de pauvreté estimé à 72,690 FCFA. L'économie du Burkina Faso est essentiellement basée sur l'agriculture et l'élevage. Les produits primaires constituent les premiers produits d'exportation dont près de 90% sont d'origine agricole. Le PIB à prix constant est passé de 752 milliards de FCFA en 1990 à 1068 milliards

en 1999, soit un taux de croissance annuel moyen de 4%. Pour les années 2000-2004, les objectifs en termes de croissance sont très ambitieux et se situent entre 7 et 8% (CSLP 2006).

Introduction à la question de la pauvreté des enfants

Le champ d'analyse de la pauvreté est très complexe et multiforme. En effet, la pauvreté n'a pas de définition unanimement reconnue car elle n'est jamais définie par elle-même, mais abordé relativement à d'autres dimensions comme l'alimentation, le logement, l'éducation, la satisfaction des besoins vitaux, etc. De ce fait l'appréhension de la pauvreté varie selon les courants de pensée économiques, les approches sociales, politiques ou anthropologiques, ou encore du point de vue des institutions internationales.

Au-delà de ces différentes approches de la pauvreté, les travaux du sommet social de Copenhague ont tenté de clarifier et d'unifier le concept de pauvreté. «La pauvreté se manifeste sous diverses formes: absence de revenu et de ressources productives suffisantes pour assurer des moyens d'existence viables; faim; malnutrition, mauvaise santé; morbidité et mortalité accrues du fait de maladie; absence ou insuffisance de logement, environnement insalubre, discrimination sociale et exclusion. Une autre caractéristique est que les pauvres ne participent pas à la prise de décision dans la vie civile, sociale et culturelle.» Kankwenda et al (1999) p 71.

Dans la politique nationale de population du Burkina Faso (2000) il ressort que la pauvreté est par conséquent, l'un des principaux obstacles aux efforts de développement du pays. Elle engendre et renforce la situation de pauvreté. En effet par le fait que la population soit pauvre, elle adopte des méthodes de production et de consommation non-viables et de ce fait, défavorables à l'environnement.

La pauvreté, qu'elle concerne des adultes ou des enfants, est un phénomène multidimensionnel: elle ne se résume pas à la seule insuffisance de ressources monétaires. Cependant ce cadre conceptuel d'appréhension de la pauvreté (la mesure de diverses composantes: conditions de vie, ressource financière mais aussi capitale culturelle ou sociale) ne s'intéresse pas spécifiquement à la situation de l'enfant d'où le nombre réduit d'études en rapport avec la pauvreté des enfants en Afrique et particulièrement au Burkina Faso.

Les quelques rares études se distinguent selon qu'elles se fondent sur des mesures unidimensionnelles du bien être des enfants ou sur des mesures indirectes. Ces mesures sont indirectes lorsqu'elles supposent une relation étroite entre le bien être du ménage et celui des enfants: «les enfants pauvres sont des enfants qui vivent dans des familles pauvres.» Matchinidé et al (2006). L'hypothèse est que les comportements internes de ces familles peuvent aggraver les conséquences sur les enfants de la pauvreté subie par leurs parents. Les études unidimensionnelles qui se focalisent sur une dimension particulière du bien être des enfants concernent la mesure de la malnutrition, de l'éducation des enfants, du travail des enfants etc.

Néanmoins, la convention relative aux droits des enfants suggère de mesurer directement la pauvreté de ces derniers et cela en relation avec leurs droits. Cette convention offre alors une base conceptuelle permettant de mesurer la pauvreté des enfants. Mesurer la pauvreté des enfants suppose alors d'évaluer leurs accès à un certain nombre de droits économiques et sociaux. «Ceci conduit d'abord à considérer que les enfants vivant au sein de ménages pauvres le sont également, même si les comportements internes à la famille peuvent alléger les conséquences sur les enfants de la pauvreté subie par leurs parents.» Dollé et al (2005). Mais, d'une manière ou d'une autre, les privations dont souffrent l'ensemble des membres d'un ménage pèsent sur les enfants. Par conséquent selon ces auteurs précédemment cités, les différents aspects de la pauvreté des familles doivent être repris dans tout système d'information sur la pauvreté des enfants.

Dans la présente revue, il sera question de présenter les déterminants de la pauvreté des enfants au Burkina Faso, de documenter son ampleur et ses conséquences à travers des indicateurs et enfin de passer en revue les solutions y afférentes.

L'état de pauvreté des enfants au Burkina Faso: Résumé Factuel

Indicateur	Year	Value
Général		
Population (millions)	2006	13,6
Proportion de la population vivant avec moins de 1 dollar	2006	27%
Population d'enfants (millions)	2006	7,6
Le PIB par habitant	2005	US \$206
Le travail des enfants	1999-2006	47%
Enregistrement des naissances		
Les naissances enregistrées avant cinq ans d'âge	1999-2006	64%
Santé et nutrition		
Les accouchements par du personnel soignant qualifié	2005	54%
Le mortalité infantile pour 1,000 naissances vivantes	2005	96
Insuffisance pondérale (modéré et grave)	2000-2006	37%
Les Enfants atteints d'une ARTI pris en charge médicalement	2000-2006	15%
Infants (âgé 12-23 mois) vaccines contre la rougeole	2005	84%
Proportion de la population utilisant des sources d'eau potable améliorés	2004	61%
Proportion de la population ayant acces a des installation d'assainissement	2004	13%
Proportion des dépenses du gouvernement central affecte au secteur de la santé	2004	15%
Éducation		
Taux de scolarisation dans le primaire (net) - filles	2004	35%
Taux de scolarisation dans le primaire (net) - garçons	2004	46%
Taux de scolarisation dans le secondaire (brut) - filles	2004	10%
Taux de scolarisaion dans le secondaire (brut) - garçons	2004	14%
Taux de scolarisation des orphelins en % de celui des non orphelins	2000-2006	71
La proportion des enseignants vis- à-vis des élèves (primaire)	2004	49
Source: Africa Development Indicators (2007), UNICEF (2007) , World Development Indicators (2007), DHS (2006), PRB (2006), MDG (2005), WSS Info (2004) and WHO (2004)		

I. Déterminants de la pauvreté des enfants

Au regard de la ligne de pauvreté de 82 672 FCFA par personne et par an on observe que 46.4% de la population burkinabé vit en dessous du seuil de pauvreté (INSD, 2003d). Par ailleurs, 56% des habitants ont moins de dix-huit ans et les femmes représentent plus de la moitié de la population du BF (UNICEF, (2008). La répartition par groupe d'âge de la population issu des données de l'enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages en 2003 confirme la jeunesse de la population. Par ailleurs, La structure de la population par grands groupes d'âges montre que les groupes ages de 20-24 ans et 25-29 ans sont les moins touchés par la pauvreté et que les plus touchés sont les enfants de moins de 15 ans qui représentent 46%.

Du point de vue du conseil de l'emploi des revenus et de la cohésion sociale française, «l'enfant est une personne, en situation de dépendance (de sa famille, de son environnement à l'école, dans son quartier, etc.) et une personne en devenir.» Bien souvent, l'enfant n'est repéré qu'au travers de ses parents et n'est pas un objet d'observation ou d'analyse en soi.

Plus précisément au Burkina le statut de l'enfant est lié a celui de sa famille en particulier de sa mère. La pauvreté de l'enfant est déterminée par celle de sa famille. Rappelons que l'enfant dispose de droits et, progressivement, de devoirs. Le non-respect de leurs droits place les enfants dans des «conditions de vie inacceptables» de pauvreté. La famille pauvre (multidimensionnel: monétaire ou sociale) n'arrive pas à respecter les droits des enfants (droits à l'éducation, à un logement décent accès aux soins de santé...). En effet, l'insuffisance ou le manque de revenus, la dislocation familiale, l'ignorance, limitent l'accès des enfants à l'éducation et l'accès des personnes malades aux soins de santé. Dans la famille pauvre, la situation des enfants est généralement précaire sur les plans de la santé, de l'éducation et de la nutrition. Quelles pourraient être alors les conséquences et les manifestations de la pauvreté chez les enfants?

1.1. Conséquence de la pauvreté des enfants et ses manifestations

Les conséquences de la pauvreté sont les effets ou impacts relatifs à la détérioration des conditions de vie. Pour Dollé et al (2005) «La pauvreté affecte non seulement le bien-être de l'enfant au moment où les ressources sont insuffisantes, mais aussi leur bien devenir.' Elle handicape leur capacité à évoluer, à se doter des ressources indispensables, comme un capital de connaissances et de savoirs, un capital culturel, un capital social, une capitale santé. Cette insuffisante construction de capital risque de conduire à ce que l'enfant pauvre devienne un adulte pauvre.»

L'INSD (2003c) a répertorié trois grandes catégories de conséquence qui sont sociale, économique et politique. Au regard de la spécificité de la pauvreté chez l'enfant; les conséquences qui en découlent sont surtout à caractère social: la délinquance ou la vie dans rue, le non-accès aux services sociaux de base (éducation de base, santé primaire, eau potable, assainissement, santé génésique, nutrition), l'exclusion sociale, la prostitution.

L'évaluation participative de la pauvreté au Burkina Faso en 2003 définit les manifestations de la pauvreté comme étant des signes distinctifs résultant de l'impact de la pauvreté. Autrement dit c'est une caractéristique lisible ou visible des conséquences de la pauvreté. Considérant la pauvreté des enfants sous l'aspect du non-respect de leur droit, il en ressort que la pauvreté de l'enfant se manifeste à travers les manifestations suivantes: l'état sanitaire et nutritionnel défectueux (la malnutrition, la faim, le non accès aux soins); le cadre de vie non décent (enfants dans la rue); le manque d'éducation (la non scolarisation, déscolarisation, le travail des enfants).

1.2. La déscolarisation-non scolarisation et le travail des enfants

L'analyse des résultats de l'enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages en 2003 révèle que le niveau de scolarisation est bas. Le taux net de scolarisation au primaire y est de 33.8%. La déscolarisation touche un élève sur cinq. Les deux principales raisons d'abandon (plus de 70% des cas) de l'école sont le renvoie et le coût élevé. Le renvoie est cependant le plus souvent dû à des résultats insuffisants de résultat. Les

données de l'EP, tout comme celle de EPI montrent que plus le niveau de vie est bas, plus la proportion des abandons pour des raisons de renvoi est élevée. Cela pourrait signifier que plus le ménage est pauvre, plus ses enfants courent le risque d'avoir des résultats insuffisants. Est-ce parce que les enfants des pauvres sont plus intelligents que ceux des non pauvres? «La principale raison pourrait provenir des conditions d'études d'autant plus que les enfants des pauvres ont moins d'opportunités notamment eu égard à l'accès aux manuels d'encadrement, à un minimum alimentaire et aux écoles à faibles effectifs» (INSD, 2003a).

Sangaré (2006) affirme que du fait de la pauvreté, beaucoup d'enfants sont obligés d'abandonner les études pour s'adonner à des activités informelles. Cela malgré l'intérêt qu'ils ont pour l'école. En effets, la dégradation de la situation économique engendre des situations de survie au niveau des ménages impliquant les jeunes qui doivent travailler. Ces stratégies sont entre autres «les jeunes loués en milieu rural pour les travaux champêtres, les aides familiaux, les jeunes placés ou confiés les jeunes employés domestiques, les jeunes dans la rue, les jeunes de la rue. La vulnérabilité de ces jeunes est la séparation de leurs familles biologiques qui entraîne un manque de sécurité et d'affection nécessaire pour qu'ils deviennent des adultes productifs» (INSD, 2003b).

Il ressort également de l'analyse de Sangaré (2006) que la quasi-totalité des parents des enfants se retrouve dans la catégorie socioprofessionnelle la plus défavorisée. Il reste cependant que la pauvreté seule n'explique pas le travail des enfants bien qu'elle en est la principale cause. En conséquence, il a pu observer dans les résultats des enquêtes que d'autres causes de ce travail sont: l'éclatement de la structure familiale, dues à des divorces, des décès ou des séparations de couples. À la question de savoir ce qui poussait les enfants à travailler, 71% avançaient des raisons de pauvreté et d'éclatement des structures familiales.

Par ailleurs l'étude spécifique sur la pauvreté et la vulnérabilité au Burkina Faso menée par INSD en 2003 décrit la situation suivante: en effet les «bonnes» qui sont surtout des jeunes filles entre 10 et 15 ans qui travaillent dans les grande villes comme bonnes à tout faire dans les familles peuvent les utiliser en dehors de la maison pour des activités lucratives (ventes de glaces, de beignets etc.). Leur rémunération varie entre 3,000 à 6,000 FCFA par moi (largement en dessous du SMIG qui est

de 24,918 FCFA par mois en 1995). Les garçons quand à eux sont souvent utilisés comme aides dans les magasins, les petits commerces certains pouvant avoir la chance d'apprendre un métier. Pour tous ces jeunes, le châtiment corporel ou les menaces de ce châtiment constituent la raison principale des fugues, contribuant à faire grossir le rang des jeunes de la rue ou dans la rue.

1.3. Les enfants dans/de la rue

Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays africains, connaît les problèmes engendrés par la dégradation des structures sociales et économiques. Cette situation touche plus les jeunes Burkinabés faisant d'eux, dans une proportion non négligeable des laissés-pour comptes. Les jeunes dans la rue sont ceux qui exercent une activité sur la voie publique mais qui ont conservé des rapports avec leurs familles ou leurs employeurs. Ils sont composés de garçons et de filles. Les jeunes de la rue sont ceux qui sont vivant et se nourrissant dans la rue. Celle-ci étant leur demeure habituelle. Ils sont surtout constitués de garçon. Dans la rue ces jeunes deviennent des travailleurs précoces (vendeurs ambulants, cireurs, gardiens de voiture, charretiers, mendiants...). Une enquête de la Croix-Rouge belge et de la Croix-Rouge burkinabé en 1,997 a fait ressortir le nombre de 7,330 enfants et jeunes de/dans la rue pour la seule ville de Ouagadougou. A cet effet, les statistiques actuelles et les plus récentes sur le phénomène sont celles qui sont basées sur une enquête menée par le ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale (MASSN) et l'UNICEF en mai 2002 dans les 49 communes de plein exercice (Samusocial, 2006). Cette enquête dénombrait 2,146 enfants de la rue, dont 525 dans la ville de Ouagadougou. Selon ces statistiques globales, 2,090 seraient des garçons et 56 des filles. Ce qui signifie d'ailleurs que le phénomène des enfants de la rue n'est pas seulement masculin.

Pour Wangré (2006), «La problématique des enfants vivant dans la rue est inséparablement liée à un contexte macro-social: effritement des rapports communautaires et familiaux, paupérisation accrue des populations des villes et des campagnes, insuffisance et faiblesse du cadre législatif...» Agés pour la plupart de 7 à 18 ans même si le groupe des enfants âgés de 5 à 7 ans croît considérablement, les enfants vivants dans la rue rencontrent des dangers et des dérives qui leur sont souvent fatals. Ils sont meurtris par les intempéries, les privations, le dénuement, les maladies, les accidents et l'indifférence. À cela s'ajoutent la précarité, la

violence, les sévices sexuels, la loi du plus fort, qui les exposent aux rencontres et influences les plus nuisibles. Tous sont très exposés aux risques: violence et abus sexuels, négligence, manque de soins de santé, manque de possibilités d'instruction et de formation professionnelle. La consommation de drogues (en particulier la colle), la petite délinquance et la prostitution aggravent encore l'état de santé mentale et physique de beaucoup de ces enfants, les marginalisent et réduisent leurs chances pour l'avenir.

Selon les conclusions de l'étude menée en mai 2002 par le Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale burkinabé sur «Les enfants et les jeunes vivant dans la rue,» «l'action menée en faveur des enfants de la rue manque de professionnalisme, de points de référence méthodologique et est souvent confrontée à des résultats très décevants du fait de l'absence de pluridisciplinarité dans la prise en charge des enfants. Privés de protection et d'affection, sans soutien familial, les enfants de la rue sont exclus des structures sanitaires, sociales et éducatives de droit commun et sont trop faibles ou trop désocialisés pour se rendre d'eux-mêmes vers les structures d'aide existantes. Leur état, tant au niveau physique que psychologique, se détériore donc très vite, d'autant qu'ils sont confrontés à des conditions de vie très dures dans la rue. Ils n'ont pas d'autre choix que de développer une stratégie de survie dans la rue en se forgeant de nouveaux repères, par le biais notamment de l'appartenance à un groupe d'enfants et d'une identification à un territoire dans la rue» (Samusocial, 2006). Abandonnés, ayant souvent subi des mauvais traitements, ces enfants développent également un fort sentiment de méfiance vis-à-vis du monde des adultes et de la société en général. Ces traits caractéristiques de la population des enfants de la rue permettent de comprendre le comportement de ces enfants, qui préfèrent rester dans la rue, où ils ont leurs repères et se sentent en sécurité, plutôt que demander de l'aide aux structures existantes.

1.4. L'état sanitaire et nutritionnel des enfants

L'étude spécifique sur la pauvreté et la santé au Burkina Faso réalisé en 2003 fait état d'une morbidité de 16.4% pour les enfants de 0 à 4 ans. L'état nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois est analysé à travers trois déterminants principaux: l'insuffisance pondérale, le retard de croissance et l'émaciation (INSD 2003b).

Le retard de croissance, ou une taille trop petite par rapport à l'âge, est la conséquence d'un apport insuffisant de nutriments sur une longue période (malnutrition chronique) et d'infections à répétition (maladie chronique) (UNICEF, 2007a). Le retard de croissance intervient généralement avant l'âge de deux ans et ses effets sont largement irréversibles. Il se traduit par un retard du développement moteur, une détérioration des fonctions cognitives et de mauvais résultats scolaires. L'étude précédemment citée révèle que la prévalence du retard de croissance est de 43.1% au Burkina Faso en 2003 pour l'ensemble des enfants de 6 à 59 mois. Or, il apparaît très clairement avec l'Unicef que l'émaciation, ou un poids trop faible pour la taille, est un important facteur prédictif de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans (UNICEF, 2007a). Elle s'explique souvent par une grave pénurie alimentaire et/ou la maladie. Elle mesure la sous-nutrition aigue (malnutrition) et était de 19.4% en 2003 chez les enfants de 6 à 59 mois. Les enfants de 48 à 59 mois sont les plus touchés avec une prévalence de 27.8%. L'insuffisance pondérale (40.30% en 2003 pour les enfants de 6 à 59 mois) peut résulter soit d'une malnutrition chronique soit d'une malnutrition aigue soit des deux.

II. Réponses développées au niveau national

2.1 Actions du gouvernement

La lutte contre la pauvreté des enfants au Burkina est intégrée dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. Il existe des programmes et projets visant à réduire les inégalités qui frappent plus de la moitié de la population: les femmes et les enfants. Au regard des liens qui existent entre la pauvreté de l'enfant et de sa famille, en particulier la mère, nous pensons que toute action qui vise à réduire la vulnérabilité d'une mère aura forcément un impact sur celles des enfants.

Certains axes du CSLP sont directement en rapport avec les personnes les plus vulnérables parmi lesquelles nous avons les enfants: la vulnérabilité étant selon INSD (2003b) «la probabilité actuelle de pénurie dans le futur. Un individu, un ménage ou une communauté est vulnérable lorsqu'il est prédisposé à certains inconvénients, exposés à des chocs, des pertes, des risques. Les risques désignant des événements incertains qui peuvent affecter le niveau de vie, comme la maladie, la vieillesse, les pertes de récolte, le chômage, la sécheresse ou les risques liés aux actions d'autres personnes ou aux décisions politiques» (INSD, 2003b) L'axe 2: garantir l'accès des pauvres aux services sociaux de base (éducation, santé, eau potable, cadre de vie décent), L'axe 3 élargir les opportunités en matière d'emploi et d'activité génératrice de revenus pour les pauvres.

De ces axes stratégiques découlent des programmes et projets centrés sur l'accélération de la croissance et l'élévation du niveau de revenu des populations ainsi que sur l'amélioration du cadre de vie et l'accès aux services sociaux essentiels.

Le Burkina Faso s'est doté d'un premier plan d'action national (1991-2000) pour réaliser les droits des enfants et mettre en œuvre des programmes.

Un comité national, crée à cet effet et composé des départements ministériels en charge de la question de l'enfance, des partenaires techniques et financiers et de la société civile, était chargé entre autres missions de suivre, évaluer et de proposer des réajustements au plan d'action. Le rapport de suivi du premier plan a été positivement apprécié et a fait l'objet d'une large diffusion. Les recommandations de son évaluation ont abouti à l'élaboration du second plan qui attend d'être adopté en Conseil des Ministres (MASSN 2007).

Sur la période 2002-2005, en termes de crédits alloués aux activités des principaux secteurs traitant des questions de l'enfant, on note un effort budgétaire considérable, passant de 130.7 milliards de FCFA à 173.5 milliards, soit un taux de progression moyen de 9.9% par an. Le Burkina Faso a consacré en moyenne 22.4% du budget national à ces secteurs. Le budget affecté à l'enseignement primaire est le plus élevé, mais reste encore faible (9.8% en moyenne). Celui de la santé (6.8% en moyenne) est en dessous des normes de l'OMS (10%). Cependant, l'indépendance vaccinale (paiement par l'Etat des vaccins réguliers du programme élargi de vaccination) est un acquis pour le Burkina Faso. Les budgets accordés à l'enseignement secondaire (5.3% en moyenne) et à l'action sociale (2.3% en moyenne) sont encore plus faibles (MASSN 2007).

En plus de ces projets et programme, il existe des orientations ciblées sur les groupes les plus défavorisés parmi lesquelles il y a les orphelins et enfants vulnérables (OEV), les enfants de la/ou dans la rue.

La lutte contre le phénomène des enfants de la rue au Burkina se traduit par la mise en place d'institutions et de structures par l'Etat à travers le MASSN. Cela reflète une volonté politique du gouvernement en matière d'encadrement et de protection de l'enfance.

L'existence de structures fermées (internats spécialisés), ouvertes et de semi-internats (action éducative et préventive en milieu

ouvert) en est le témoignage. Cette volonté politique est renforcée par l'adoption de textes législatifs et réglementaires en matière de protection des enfants. Les autorités se sont engagées à respecter les grands principes internationaux contenus dans les différentes déclarations, et à ratifier plusieurs conventions.

Le Burkina Faso a adopté une politique nationale d'action sociale en Avril 2007. Le MASSN dispose désormais d'une politique publique prenant en compte toutes les problématiques d'action sociale et économiques ainsi que les stratégies pour y répondre. Cette politique va permettre de mobiliser d'avantage de ressources financières et de partenaires sur les problématiques sociales de façon générale. Il est prévu d'ailleurs, de convoquer une table ronde des PTF pour l'opérationnalisation de cette politique (BIT/PEC/LUTRENA, 2007)

Il existe tout un ensemble d'instruments juridiques de protection de l'enfant au plan national et international. Pour le cas spécifique des enfants vivant dans la rue, dès 1991, la loi n°19/61 AN relative à l'enfance délinquante ou en danger a été promulguée. Cette loi sera complétée par celle n°11/64 AN portant réglementation de la circulation des mineurs, de leur fréquentation des débits de boissons, des bars dancings, des salles de cinéma et de spectacles.

2.2 Actions des institutions et ONGs

L'UNICEF s'emploie à combattre la pauvreté, à améliorer les conditions de vie des enfants et des femmes, et à contribuer à la réalisation des droits de l'enfant au Burkina Faso.

Son programme de santé cherche à améliorer la survie de l'enfant en réduisant la mortalité infantile au moyen de la vaccination et de l'apport de micronutriments complémentaires. Le bureau de pays veille également à ce que les femmes suivent une formation à la santé, à la nutrition et à l'hygiène. En outre, la collaboration entre l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a permis de réduire de 40% le nombre de cas de dracunculose.

En ce qui concerne la santé des femmes, l'une des activités entreprises depuis l'adoption en 1996 d'une loi contre la mutilation génitale féminine consiste à veiller au respect de cette loi dans les sept provinces.

En matière d'éducation, l'UNICEF Burkina Faso contribue à dispenser une éducation de base aux enfants âgés de 7 à 14 ans, au moyen d'initiatives telles que la création d'écoles satellites. L'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'utilisation des langues nationales comme moyenne d'instruction ont également permis d'améliorer les résultats scolaires.

En matière de protection de l'enfance, le bureau de pays appuie les efforts déployés par le Gouvernement et la société civile en vue de promouvoir le respect et l'application des droits de l'enfant. Le programme de mobilisation et de protection contribue à faire connaître la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le Burkina Faso a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, mais conformément aux recommandations formulées dans son premier rapport,

Sur initiative de l'UNICEF, un cadre de concertation des PTF pour la protection de l'enfance avec la participation des ONGs a été mis en place. Au niveau de ce groupe, une cellule restreinte de 06 personnes a été créée pour assurer l'animation du cadre qui regroupe ainsi des représentants de plusieurs secteurs : des bilatéraux, des multilatéraux, des représentants de l'Etat, et des représentants d'ONG). Il s'agit d'un cadre partenarial pour la promotion et la protection de l'enfance» (BIT/IPEC/LUTRENA, 2007).

l'administration de la justice pour mineurs aurait besoin d'une aide de la communauté internationale. En collaboration avec les organisations non gouvernementales, l'UNICEF participe à ces efforts en plaidant en faveur de l'amélioration des conditions de détention des mineurs à la prison de Ouagadougou.

De nombreuses ONG nationales et internationales participent activement à la mobilisation des ressources et mettent en œuvre des actions basées sur les droits des enfants au Burkina Faso.

Le dialogue et la concertation entre institutions étatiques, institutions internationales et ONG se fait de plus en plus à l'intérieur d'un cadre institutionnalisé pour plus d'efficacité dans la promotion et la protection des droits des enfants.

III. Recommandations

En rappel, nous dirons que la question de la pauvreté des enfants est assez complexe et multiforme. De toute évidence et après le constat qui vient d'être fait les réponses à apporter ne doivent pas et ne peuvent être multiforme et surtout multisectoriel. Il nous semble que la difficulté est d'adresser la question sur le plan exclusif de la pauvreté économique. Aussi une série de mesures et d'actions peut être proposé!

- Assurer une meilleure connaissance de la problématique avec des données évidentes: l'analyse de l'incidence de la pauvreté ne doit pas s'arrêter aux ménages de façon globale mais intégrer de façon spécifique les enfants surtout du point de vue des conséquences.
- Mettre en place des programmes de réinsertion socio-économique et professionnelle ciblant les enfants et ayant pour objectif en soi la lutte contre la pauvreté des enfants.
- Renforcer l'accès aux services sociaux de base pour réduire l'impact de la pauvreté. Une expérience en cours consiste à donner un accès gratuit aux fournitures et autres manuels scolaires; ce type d'exemples doit être multiplié. Au niveau de la santé le principe de la gratuité des soins pour les personnes indigentes y compris les enfants s'inscrit dans la politique de développement sanitaire. Cependant il y'a très peu d'application. Or il s'agit là d'une question d'équité et de justice sociale qu'il va falloir résoudre en toute urgence.
- Promouvoir les programmes de réhabilitation et de renforcement socio-économique intégrés dans des programmes plus larges de prise en charge de l'enfance vulnérable (trafic des enfants, lutte contre les violences faites aux enfants, prise en charge des orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH/SIDA) qui doivent être renforcés.
- Documenter les bonnes pratiques en matière de réhabilitation socio-économique ciblant les enfants et les diffuser.
- Initier des programmes de sensibilisation sur la pauvreté des enfants et entreprendre des actions de plaidoyer auprès des décideurs.
- Considérer les enfants en situation de pauvreté comme cibles prioritaires dans les programmes de réduction de la pauvreté.

Conclusion

La pauvreté des enfants est très peu documentée au Burkina Faso. Sur la base des études sur les conditions de vie des ménages nous avons essayé de faire une revue de la question.

En conclusion, nous pouvons dire que les enfants vivants dans les ménages pauvres burkinabé le sont plus ou moins car ces ménages sont incapables de respecter les droits de ces enfants, lesquels droits sont indispensables au bien être de l'enfant.

Références bibliographiques

- BIT/IPEC/LUTRENA (2007). «Analyse situationnelle de la traite des enfants dans la zone de couverture de LUTRENA (2001-2006): Faits marquants.»
- DHS Statcompiler accessed at www.statcompiler.com
- Dollé, M., Bruniaux, C. and Galtier, B. (2005). «Estimer la pauvreté des enfants» dossier n°2 du Conseil Emploi Revenu et Cohésion social. CRC, Paris, 36p.
- INSD (2003a). «Analyse des résultats de l'enquête Burkinabé sur les conditions de vie des ménages, rapport final» Ouagadougou 45p.
- INSD (2003b). «Étude spécifique sur pauvreté et vulnérabilité au Burkina Faso» Ouagadougou, 77p.
- INSD (2003c). «Évaluation participative de la pauvreté: processus systématique de consultation» Ouagadougou, 173p.
- INSD (2003d). «Le Burkina Faso : la pauvreté en 2003,» Ouagadougou, 12p.
- INSD (2002). «Études spécifiques sur le genre et la pauvreté au Burkina Faso» Ouagadougou, 71p.
- Kaboré, B., Somé, R. and Paré, L. (2002). «Études spécifiques sur la pauvreté et la santé au Burkina Faso,» INSD, Ouagadougou 95p.
- Kankwenda, M., Grégoire, L-C. and Ouédraogo, H. (1999). «La lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne» PNUD, 465p.
- Matchinidé, S., Vinaha, T.N., Apété-Matongo, S. and Zabalo, E. (2006). «Pauvreté multidimensionnelle des enfants et des ménages: analyse appliquée à la république centrafricaine» CRDI, 26p.
- UN Millennium Development Indicators database accessed at <http://mdgs.un.org.unsd/mdg/Data.asp>

- Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale (2007).
«Rapport de suivi de la position commune africaine: "une Afrique digne des enfants."»
- Population Reference Bureau (PRB) (2006). World Population Data Sheet 2006.
- Samusocial Burkina Faso (2006). «Améliorer les prise en charge des enfants de la rue à Ouagadougou: rapport annuel.» Ouagadougou, B F, 61p.
- Sangaré, A. (2006). «Le travail des enfants en milieu urbain: études de cas de l'agglomération de Ouagadougou (Burkina Faso)», in cahiers du CERLESHS n° 25 pp 274-301.
- UNICEF (2008). «Burkina Faso : priorités de l'UNICEF» in www.unicef.org/french/sowc/
- UNICEF (2007a). «Un monde digne des enfants : bilan statistique» in progrès pour les enfants n° 6 New York, US, 72p.
- UNICEF (2007b). «La situation des enfants dans le monde 2008: la survie de l'enfant» New York, US, 164p.
- UNICEF, (2007c). Monitoring the Situation of Children and Women 2007 accessed at www.childinfo.org
- Wangé, N.J. (2008). «Enfants de la rue: de l'innocence à la menace sociale...» In <http://www.lefaso.net>
- WHO National Health Accounts (NHA) accessed at www.who.int/nha/country/en/index.html
- World Bank, (2007). Africa Development Indicators 2007.
- World Bank, (2007). World Development Indicators 2007.
- WSS info WHO and UNICEF Joint Monitoring Programme for water and sanitation accessed at www.wssinfo.org



P.O. Box 1179, Addis Ababa, Ethiopia
Telephone: +251 116 62 81 92/96
Fax: +251 116 62 82 00
E-mail: info@africanchildforum.org
www.africanchild.info
www.africanchildforum.org

© 2009 African Child Policy Forum